

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Azithromycin 10mg/mL

(아자사이트점안액, 신풍제약(주))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1mL 중 Azithromycin 10mg

☐ **효능 효과 :**

- 유효균종: 헤모필루스 인플루엔자, 황색포도상구균, 연쇄구균 속, 폐렴연쇄구균
- 적응증: 감수성 세균에 의한 만 1세 이상 소아 및 성인의 세균성 결막염

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의일**

2011년 제13차 약제급여평가위원회 : 2011년 10월 20일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 비급여

- 신청품은 “감수성 세균에 의한 만 1세 이상 소아 및 성인의 세균성 결막염”에 허가 받은 약제로 대체약제 대비 임상적 유용성 개선이 불분명하고 투약비용이 대체약제의 포장단위당 가중소요비용보다 고가로 비용효과성이 불분명하므로 비급여함.
- 단, 제약사()가 대체약제의 가중평균가() 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “감수성 세균에 의한 만 1세 이상 소아 및 성인의 세균성 결막염”에 허가 받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 ofloxacin, tobramycin, levofloxacin 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려 시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 nitrogen을 함유한 macrolide(azalide)계 항균제로, 교과서에 수재되어 있으며¹⁾²⁾ 가이드라인에는 검색되지 않음.
- 경증의 결막염은 면역능력이 있는 성인에서는 특별한 치료 없이 저절로 해결됨. 대부분의 흔한 세균성 결막염과 관련한 기간, 재발률, 이환율은 국소항생제 요법으로 감소될 수 있으며 항생제 선택은 보통 경험에 의함. 5-7일 코스의 광범위 국소항생제가 보통 효과적이며, 가장 저렴한 것이 선택될 수 있음.³⁾⁴⁾
 - 국소항생제를 비교한 다기관 무작위 대조군 임상시험에서(norfloxacin 0.3%, ciprofloxacin 0.3%, ofloxacin 0.3%, lomefloxacin 0.3%, levofloxacin 0.5%, chloramphenicol 0.5%; sulfacetamide sodium 10%, erythromycin 5mg/g, gentamicin sulfate 0.3%, trimethoprim sulfate-polymyxin B 10,000U/1mg/1ml, fusidic acid 0.1%, tobramycin 0.3%) clinical 또는 microbial 치료율에 있어서 유의미한 차이가 없었음.⁵⁾
- 세균성 결막염으로 진단된 환자 316명을 대상으로 이중맹검 3상 임상시험을 수행하여 6-7일째 임상적 치료효과를(PP분석) 평가한 결과 1.0% azithromycin 5일 투여군은 0.3% tobramycin 5일 투여군과 임상적 증상이 소실⁶⁾된 환자비율에 유의한 차이가 없었음.(79.9% vs 78.3%, difference:1.5%, p=0.783)⁷⁾

- 세균성 결막염으로 진단된 환자 743명을 대상으로 이중맹검 3상 임상시험을 수행하여 내성과 안전성을 평가한 결과 1.0% azithromycin 5일 투여군 3%, 0.3% tobramycin 5일 투여군 5.6%가 이상반응이 나타났으며, 가장 빈번한 이상반응은 눈자극 1.9%, 충혈 1.1%, 결막염악화 1.1%였음.⁸⁾

○ 비용 효과성

- 세균성 결막염에 사용되는 약제 11개 성분⁹⁾ 중 상위 3품목이 전체 청구량의 ■■■ 이상을 차지하는 점을 고려하여, 대체약제를 ofloxacin, tobramycin, levofloxacin 로 선정함¹⁰⁾.
- 해당 적응증이 급성질환임을 고려하여 포장단위당 가중 소요비용을 비교시, 신청품(■■■■)은 대체약제 가중평균가인 ■■■■ 대비 고가임.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 포장단위당비용은 ■■■■ 임.

○ 재정 영향¹¹⁾

- 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상사용량¹²⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹³⁾은 1차 년도에 약 ■■■■ 원, 3차 년도에 약 ■■■■ 원이 되고, ofloxacin, tobramycin, levofloxacin의 대체로 재정소요금액¹⁴⁾은 1차 년도에 약 ■■■■ 원, 3차년도에 약 ■■■■ 원 증가될 것으로 예상됨¹⁵⁾
- 대체가능약제 중 소량 청구품목으로 대체약제에 포함되지 않은 품목을 고려 시 실제 재정 증감액에 변동이 있을 수 있음

- 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 제약사 제출 예상사용량¹⁶⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁷⁾은 1차 년도에 약 ■■■■ 원, 3차 년도에 약 ■■■■ 원이 되고, ofloxacin, tobramycin, levofloxacin의 대체로 인한 재정증분은 없음

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국에 등재되어있음.

Reference

- 1) Cornea 3rd edition, 2011
- 2) Pharmacotherapy-Principles and Practice 2nd edition, 2010
- 3) Conjunctivitis, american academy of ophthalmology and preferred practice pattern, 2008
- 4) American Optometric Association. Care of the patient with conjunctivitis. 2nd edition
- 5) Guidelines for the treatment and management of acute bacterial conjunctivitis in children and adult, University of Texas, School of Nursing, Family Nurse Practitioner Program. Guidelines for the treatment and management of acute bacterial conjunctivitis in children and adults. Austin (TX): University of Texas, School of Nursing; 2005 May. 21p.
- 6) clinical resolution(임상적 증상 소실)= visit 3(6-7일)에 세균성 결막염의 3가지 임상증상(안구분비물, 안구결막충혈, 안검충혈)의 소실
- 7) Abelson et al, A randomized trial assessing the clinical efficacy and microbial eradication of 1% azithromycin ophthalmic solution vs tobramycin in adult and pediatric subjects with bacterial conjunctivitis. *clin Ophthalmol* 2007 1(2): 177-182
- 8) Protzko et al, Phase 3 safety comparisons for 1.0% azithromycin in polymetric mucoadhesive eye drops versus 0.3% tobramycin eye drops for bacterial conjunctivitis. *invest ophthalmol vis sci.* 2007 48: 3425-3429
- 9) 2011년 10월 급여목록기준, 0.3% ofloxacin, 0.3% tobramycin, 0.5% levofloxacin, 0.3% gentamicin sulfate, 0.5% moxifloxacin HCl, 0.3% gatifloxacin, 0.1% fusidic acid, 0.3% norfloxacin, 0.3% ciprofloxacin, 0.3% micronomicin sulfate, besifloxacin 0.6%
- 10) 대체약제 가중평균가 산출 시 위원회 별도 심의 사항(신약 등 협상대상약제 세부평가기준)
 - 소량 청구품목이 다수 등재되어 있는 등 분석의 어려움이 있는 경우에 사용량 등을 고려
- 11) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 12) 제약사 제출 예상사용량(1차년도: ■■■■■ 병, 2차년도: ■■■■■ 병, 3차년도: ■■■■■ 병)
- 13) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 신청약가
- 14) 재정증감액=(신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제시 예상사용량
- 15) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.
- 16) 제약사 제출 예상사용량(1차년도: ■■■■■ 병, 2차년도: ■■■■■ 병, 3차년도: ■■■■■ 병)
- 17) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 가중평균가